

TEMA 6.3 • INFECTOLOGÍA

Síndrome Mononucleósico, Síndrome Retroviral Agudo y TORCH

PERFIL EUNACOM 1.05.1.003

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Síndrome Mononucleósico, Síndrome Retroviral Agudo y TORCH

I. Síndrome Mononucleósico

Triada clínica

Odinofagia + Fiebre + Adenopatías cervicales

Causas frecuentes

- Virus de Epstein-Barr (VEB) — causa más frecuente - Citomegalovirus (CMV) - VIH (primo-infección) - Adenovirus, Herpes, Toxoplasma, Bartonella, Linfoma

Clínica específica de Mononucleosis por VEB

- Esplenomegalia ± hepatomegalia - **Ictericia** (hepatitis) - Rash morbiliforme → sube de 30% a **90%** con aminopenicilinas (amoxicilina, ampicilina) → NO ES ALERGIA al ATB, es parte del cuadro - Linfocitosis con linfocitos atípicos en hemograma

Diagnóstico

- **IgM VCA** (antígeno de cápside viral del VEB) → examen de elección - Si IgM-VCA negativa → buscar CMV, Toxoplasma, etc. - Anticuerpos heterófilos (Paul-Bunnell): obsoletos pero pueden aparecer en preguntas

Tratamiento

Sintomático — No existe antiviral específico para VEB.

II. Síndrome Retroviral Agudo (Primo-Infección VIH)

Clínica

- Síndrome mononucleósico + exantema rosado inespecífico. - Requiere **antecedente de riesgo** para sospecharlo: contacto sexual de riesgo, accidente cortopunzante, transfusión reciente.

Diagnóstico

- **PCR para VIH** o **Antígeno p24** — exámenes de elección. - El ELISA está **en período de ventana** en la primo-infección → falsamente negativo.

Tratamiento

- Triterapia antirretroviral (TARV) — se inicia a todos los pacientes VIH hoy en día.

III. Infecciones TORCH (Infecciones Congénitas)

TORCH = **Toxoplasma** | **O**tros (Sífilis, Chagas, VZV, Zika) | **R**ubéola | **CMV** | **H**erpes Simple

Principio general

El riesgo de TORCH ocurre con la **primo-infección en el inicio del embarazo** (1er trimestre), no con las recurrencias. - Excepción: Sífilis y Chagas (crónicas) pueden causar TORCH en cualquier momento.

Manifestaciones generales

Malformaciones cardíacas, oculares, cerebrales. Microcefalia con retraso mental.

Por agente

TABLA 6.3.1: AGENTE VS CLÍNICA ESPECÍFICA

AGENTE	CLÍNICA ESPECÍFICA
CMV (más frecuente)	RCIU, microcefalia, hepatoesplenomegalia, calcificaciones cerebrales periventriculares
Toxoplasma	Similar a CMV pero con mayor riesgo de hidrocefalia
Rubéola	Catarata congénita, microcefalia, cardiopatía congénita (CIA, CIV, ductus)

Screening durante el embarazo

- Se pide **IgG** para CMV y Toxoplasma al inicio del embarazo. - IgG (+) → Inmune, sin riesgo. Tranquilizar. - IgG (-) → Paciente susceptible → Prevención (evitar alimentos crudos en toxoplasma). - Si hay síndrome mononucleósico en embarazada → pedir **IgM** para descartar primo-infección.

Tratamiento

- Toxoplasma en embarazada con primo-infección → **Sulfadiazina** (pese a ser contraindicada en embarazo, el riesgo de TORCH es mayor).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Adolescente de 17 años consulta por odinofagia intensa, fiebre y adenopatías cervicales bilaterales. Al examen: esplenomegalia. Se inicia amoxicilina y a las 48 horas desarrolla rash morbiliforme generalizado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Síndrome Mononucleósico, Síndrome Retroviral Agudo y TORCH. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Síndrome mononucleósico: odinofagia + fiebre + adenopatías cervicales. Virus Epstein-Barr es la causa más frecuente del cuadro clásico.
- Rash con aminopenicilinas (amoxicilina, ampicilina) en mononucleosis aumenta de 30% a 90%. No es alergia, es parte del cuadro.
- Diagnóstico mononucleosis: IgM VCA. Hemograma con linfocitosis y linfocitos atípicos.
- Síndrome retroviral agudo: primoinfección VIH con síndrome mononucleósico + rash + antecedente de riesgo. ELISA falsamente negativo (período de ventana). Diagnóstico con PCR VIH o antígeno P24.
- TORCH: primoinfección al inicio del embarazo. CMV es la causa más frecuente (RCIU, microcefalia, hepatoesplenomegalia, calcificaciones cerebrales).
- Screening TORCH: IgG para toxoplasma y CMV. IgG positiva = sin riesgo. IgG negativa = riesgo, evitar fuentes.
- IgM se pide solo ante clínica de primoinfección en embarazada. IgM positiva = tratar (toxoplasma con sulfas).

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SÍNDROME MONONUCLEÓSICO, SÍNDROME RETROVIRAL AGUDO Y TORCH)**PREGUNTA 1**

Adolescente de 17 años consulta por odinofagia intensa, fiebre y adenopatías cervicales bilaterales. Al examen: esplenomegalia. Se inicia amoxicilina y a las 48 horas desarrolla rash morbiliforme generalizado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Alergia a amoxicilina tipo reacción cutánea
- B)** Mononucleosis infecciosa por virus Epstein-Barr
- C)** Amigdalitis bacteriana por estreptococo grupo A
- D)** Síndrome retroviral agudo por VIH
- E)** Infección por citomegalovirus

PREGUNTA 2

Hombre de 28 años con antecedente de promiscuidad sexual consulta por odinofagia, fiebre, adenopatías y exantema rosado tenue de 5 días de evolución. ELISA VIH resulta negativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Descartar VIH, el ELISA negativo confirma que no tiene la infección
- B)** Solicitar PCR para VIH o antígeno P24
- C)** Repetir ELISA en una semana
- D)** Solicitar IgM VCA para descartar mononucleosis
- E)** Iniciar aciclovir por sospecha de herpes

PREGUNTA 3

Embarazada de 10 semanas con IgG negativa para toxoplasma al inicio del embarazo. ¿Cuál es la indicación más importante?

- A)** Iniciar tratamiento profiláctico con sulfas
- B)** Evitar contacto con gatos exclusivamente
- C)** Comer todos los alimentos bien cocidos y evitar fuentes de infección
- D)** Solicitar IgM para toxoplasma de inmediato
- E)** No requiere medidas especiales ya que la IgG negativa indica protección

RESUMEN: SÍNDROME MONONUCLEÓSICO, SÍNDROME RETROVIRAL AGUDO Y TORCH

Esta clase aborda tres temas interrelacionados. El síndrome mononucleósico se presenta con odinofagia, fiebre y adenopatías cervicales, causado por múltiples agentes (VEB, CMV, VIH, adenovirus, etc.). La mononucleosis infecciosa por virus Epstein-Barr es la causa más frecuente, con esplenomegalia, hepatomegalia, ictericia y rash morbiliforme (30%, que aumenta a 90% con aminopenicilinas). El diagnóstico es con IgM VCA. El hemograma muestra linfocitosis con linfocitos atípicos. Tratamiento sintomático. El síndrome retroviral agudo es la primoinfección por VIH, con clínica de síndrome mononucleósico más rash y antecedente de riesgo (promiscuidad sexual, accidente cortopunzante). El ELISA está falsamente negativo (periodo de ventana), por lo que se diagnostica con PCR para VIH o antígeno P24. El tratamiento es triterapia antirretroviral. TORCH se refiere a infecciones congénitas: Toxoplasma, Otros (sífilis, Chagas, varicela, Zika), Rubéola, Citomegalovirus y Herpes simplex. Se produce por primoinfección al inicio del embarazo (excepto infecciones crónicas como sífilis y Chagas). El CMV es la causa más frecuente, con RCIU, microcefalia, hepatoesplenomegalia y calcificaciones cerebrales. El screening se hace con IgG para toxoplasma y CMV; IgG positiva descarta riesgo, IgG negativa indica riesgo. La IgM se pide solo ante clínica de primoinfección en embarazada.